MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

Jerarquía de la evidencia

La jerarquía de la evidencia es el mapa mental que todo MSL usa para decidir, en segundos, cuánto peso dar a un dato antes de compartirlo con un profesional sanitario. Se representa como una pirámide: en la base están los estudios in vitro y en modelos animales, que generan hipótesis pero no prueban eficacia en humanos; encima, las series de casos y los estudios observacionales (cohortes, casos y controles), que muestran asociaciones en la práctica real pero sin control de todas las variables; más arriba, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados (ECA), el estándar para establecer causalidad porque la aleatorización reparte los factores de confusión conocidos y desconocidos entre los brazos de tratamiento; y en la cúspide, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que combinan de forma metódica los resultados de múltiples ECA para aumentar la precisión estadística y detectar consistencia entre estudios.

Pirámide de la evidencia

→ **Estudios in vitro y en animales**
→ **Series de casos y estudios observacionales**
→ **Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)**
→ **Revisiones sistemáticas y metaanálisis**

Entender esta jerarquía no es un ejercicio académico: es lo que permite a un MSL responder con honestidad a la pregunta "¿qué tan sólida es esta evidencia?" en lugar de tratar todos los datos como si tuvieran el mismo valor. Un estudio observacional que muestra una asociación entre un fármaco y un resultado puede ser genuinamente útil —sobre todo para generar hipótesis o entender la práctica real— pero no permite afirmar causalidad de la misma manera que un ECA bien diseñado. Confundir ambos niveles, o presentarlos con el mismo peso ante un HCP, es un error tanto científico como ético.

- Permite responder con honestidad qué tan sólida es una evidencia
- Un estudio observacional sugiere asociación, no causalidad como un ECA
- Confundir ambos niveles es un error tanto científico como ético

La jerarquía también tiene matices importantes que un MSL competente debe manejar. No toda revisión sistemática es automáticamente superior a un ECA individual: la calidad depende de qué estudios se incluyeron y cómo se combinaron. Un ECA pequeño, con un intervalo de confianza muy amplio, puede aportar menos certeza que un estudio observacional muy grande y bien controlado con métodos estadísticos avanzados (como el emparejamiento por puntuación de propensión). Por eso, algunas propuestas metodológicas recientes sugieren que la jerarquía no debe entenderse

como una escalera rígida, sino como una guía flexible que debe combinarse siempre con una evaluación crítica del diseño, el tamaño muestral, el riesgo de sesgo y la relevancia clínica de cada estudio concreto.

- No toda revisión sistemática es automáticamente superior a un ECA individual
- Un ECA pequeño con IC amplio puede dar menos certeza que un gran estudio observacional
- La jerarquía es una guía flexible, no una escalera rígida

Para un MSL, dominar la jerarquía de la evidencia tiene tres aplicaciones prácticas inmediatas. Primero, permite filtrar la avalancha de información científica disponible y priorizar qué leer en profundidad: un metaanálisis reciente en una revista de alto impacto merece más atención inicial que un caso clínico aislado. Segundo, permite calibrar el lenguaje al comunicar: hablar de "asociación" cuando el diseño es observacional, y de "efecto" o "beneficio demostrado" solo cuando el diseño lo permite. Tercero, ayuda a anticipar las objeciones de los HCP más críticos, que con frecuencia preguntan directamente por el diseño del estudio antes de aceptar una conclusión.

3 APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA JERARQUÍA

1. Filtrar
Priorizar qué leer en profundidad según el nivel de evidencia

2. Calibrar lenguaje
Decir "asociación" o "efecto demostrado" según el diseño

3. Anticipar objeciones
Prepararse para preguntas de HCP sobre el diseño del estudio

En última instancia, la jerarquía de la evidencia es el lenguaje común entre el MSL y la comunidad médica y científica: hablarlo con precisión genera credibilidad, mientras que ignorarlo —o usarlo de forma selectiva para reforzar un mensaje comercial— erosiona la confianza que sostiene toda la función de Medical Affairs.

- La jerarquía es el lenguaje común entre el MSL y la comunidad científica
- Hablarla con precisión genera credibilidad
- Usarla de forma selectiva erosiona la confianza en Medical Affairs